

2. Déroulement du séminaire

Déroulement et objectifs spécifiques

Le séminaire dure deux heures. Nous suggérons de le diviser en deux parties.

La première mettra l'accent sur la prise d'une anamnèse urologique. Au moyen d'un jeu de rôle (exemple en annexe à la fin du guide), on présentera d'abord une histoire typique de colique néphrétique. On discutera les éléments essentiels de l'anamnèse d'une douleur du flanc urologique ainsi que son diagnostic différentiel. Ensuite, on présentera les troubles mictionnels et leurs causes.

Dans la deuxième partie, on démontrera l'examen clinique des loges rénales et d'un globe urinaire. Le toucher rectal sera illustré sur un modèle artificiel.

L'anamnèse sexuelle et l'examen des organes génitaux masculins seront étudiés en 4e et 5e années.

1. Anamnèse

Savoir-faire l'anamnèse d'une douleur aiguë du flanc au travers d'un jeu de rôle.

- Mode d'apparition, type de douleur, facteurs déclenchants, position antalgique, irradiation, traumatisme antérieur, antécédents, troubles du transit ou de la miction, etc.
- Anamnèse familiale (cystinurie).
- Préciser les risques d'une septicémie sur pyonéphrose obstructive.
- Présenter les différentes causes de colique néphrétique (calculs, caillots, maladie de la jonction pyélo-urétérale, nécrose papillaire).
- Introduire le diagnostic différentiel (musculo-squelettique, digestif, gynécologique).

Savoir-faire l'anamnèse des troubles mictionnels.

- Dysurie (à différencier de l'algurie, ce que ne fait pas le Swartz p. 364).
- Algurie, pollakiurie, pneumaturie, fécalurie, pyurie.
- Les différents types d'incontinence.
- Hématurie (initiale, terminale, totale).

2. Examen physique

Démonstration par le formateur sur un étudiant, puis examen physique des étudiants entre eux.

Introduction à l'examen de l'abdomen

- Inspection, auscultation, percussion, palpation.
- Se réchauffer les mains.
- Débuter par le côté non douloureux.
- Savoir distraire un éventuel patient démonstratif ou fictif.

Loges rénales :

- Palpation des reins.
- Bimanuelle.
- Examineur du côté homolatéral ou controlatéral.
- Rein gauche plus haut que le droit.
- Palpation le plus souvent que du pôle inférieur ou négative chez le sujet obèse.
- Percussion des loges rénales ou ébranlement.

Vessie :

- Palpation-percussion d'une vessie pleine (avertir les étudiants avant le CC, afin qu'au moins deux d'entre eux se présentent "vessie pleine").

Toucher rectal (modèle artificiel):

- Inspection, tonus sphinctérien, rectum, Douglas, col utérin.
- Prostate: taille, consistance, surface, sensibilité.
- Adénome / cancer.